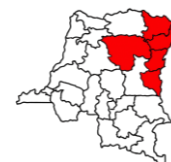




TASK FORCE PRESIDENTIELLE EBOLA 17
Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale
Institut National de Santé Publique
Centre d'Opérations d'Urgence de Santé Publique
Système de gestion de l'incident MVE17



Rapport de Situation de la 17^{ème} Épidémie de la Maladie à Virus EBOLA /RDC

SitRep N°104/MVEBDB/26/08/2026

Date de rapportage : 26 août 2026

Date de publication : 27 août 2026



FAITS SAILLANTS (dernières 24h)

Au terme de la journée du 26 août 2026, **81 nouveaux cas confirmés** dont **35 décès communautaires** de la Maladie à Virus Ebola (MVE) ont été enregistrés dans les provinces de l'Ituri (52 cas), du Nord-Kivu (22 cas), Haut Uélé (5) et Tshopo (2). De plus, **7 décès intra-CTE** ont été enregistrés.

Deux nouvelles zones de santé touchées au cours de dernières 24h dans la province du Nord-Kivu.

CUMUL DES CAS 5 794	CUMUL DES DÉCÈS CONFIRMÉS 2 786	LETALITE 48,1%	PATIENS EN ISOLEMENT/CTE 843	CUMUL DES GUÉRIS 1 293	TAUX DE SUIVI DES CONTACTS (Du Jour) 82,3 %
--	--	-------------------------------------	---	---	--



Provinces touchées et Zones de santé touchées



6 Provinces touchées

Haut-Uélé, Ituri, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Tshopo & Bas Uélé



60 Zones de santé touchées sur 151

(39,7%)



Résumé des points clés au cours de dernières 24 heures

Au cours des dernières 24 heures, **81 nouveaux cas confirmés** dont **35 décès communautaires** de la Maladie à Virus Ebola (MVE) ont été rapportés dans les provinces de l'Ituri (52 cas), Nord-Kivu (22), Haut Uélé (5) et Tshopo (2).

Deux nouvelles zones de santé ont été touchées dans la province du Nord-Kivu, en l'occurrence celles de Biena et Manguredjipa.

En date du 26 août 2026, **24 patients** ont été déclarés guéris après avoir obtenu deux résultats négatifs à la MVE (12 en Ituri, 11 au Haut Uélé et 1 au Nord Kivu). D'autre part, **7 décès intra-CTE** ont été enregistrés, dont 5 en Ituri, 1 au Nord Kivu et 1 au Haut Uélé. Ce qui porte **le nombre des décès du jour à 42**.

Depuis le début de l'épidémie jusqu'au 26 août 2026, **5 794 cas confirmés** dont **2 786 décès** ont été rapportés en RDC, soit une létalité de **48,1 %**. L'Ituri demeure l'épicentre de l'épidémie, concentrant **82,9 %** des cas confirmés cumulés et **64,2 %** des nouveaux cas rapportés.

Ainsi, 60 des 151 zones de santé des six provinces sont désormais affectées depuis le début de l'épidémie en RDC. L'Ituri compte 28 zones de santé touchées sur 36, suivi du Nord-Kivu (15/34), du Haut-Uélé (6/13), de la Tshopo (7/23), du Sud-Kivu (1/34) et Bas Uélé (3/11).

Répartition des cas et décès confirmés par province touchée
(Au 26 août 2026)

Province	Nouveaux cas confirmés(24h)	Cas confirmés	Décès (confirmés)	Létalité	Zones de santé touchées
Ituri	52	4802	2 159	45,0%	28/36 (77,8 %)
Nord-Kivu	22	775	527	68,0%	15/34 (44,1 %)
Haut-Uélé	5	194	90	46,4%	6/13 (46,1 %)
Tshopo	2	17	8	47,1%	7/23 (30,4 %)
Sud-Kivu	0	3	1	33,3%	1/34 (2,9 %)
Bas Uélé	0	3	1	33,3%	3/11(27,3%)
Total	81	5 794	2 786	48,1%	60/151 (39,7 %)

Cas et décès confirmés par province et zone de santé (situation du 26 août 2026)

Province / Zone de santé	Nombre cumulatif			Situation du jour (24h)			
	Cas (n)	Décès (n)	Létalité	Nouv. Cas	Décès communautaires (Swab+)	Décès confirmés intra-CTE	Total décès confirmés
Ituri	4802	2159	45,0%	52	21	5	26
Adja	11	1	9,1%				0
Aru	7	6	85,7%				0
Ariwara	8	2	25,0%				0
Aungba	12	5	41,7%				0
Bambu	149	29	19,5%	1	0	0	0
Boga	2	2	100,0%				0
Bunia	1336	421	31,5%	19	10	0	10
Damas	27	9	33,3%				0
Drodro	13	6	46,2%				0
Fataki	73	30	41,1%				0
Gethy	5	2	40,0%				0
Kambala	2	0	0,0%				0
Kilo	32	12	37,5%				0
Komanda	65	42	64,6%	4	3	0	3
Lita	204	111	54,4%				0
Logo	11	5	45,5%				0
Lolwa	19	4	21,1%				0
Mahagi	4	1	25,0%				0
Mambasa	17	7	41,2%				0
Mandima	33	19	57,6%	1	0	0	0
Mangala	212	114	53,8%	9	5	0	5
Mongbwalu	606	284	46,9%	1	0	0	0
Nia-Nia	199	108	54,3%				0
Nizi	636	254	39,9%	8	2	0	2
Nyankunde	124	35	28,2%				0

Rimba	10	4	40,0%				0
Rwampara	930	336	36,1%	9	1	0	1
Tchomia	55	25	45,5%				0
A ventiler	NA	285	NA	NA	NA	5	5
Nord-Kivu	775	527	68,0%	22	14	1	15
Beni	122	87	71,3%	4	2		2
Biena	1	1	100,0%	1	1		1
Butembo	152	116	76,3%	6	6		6
Goma	1	0	0,0%				0
Kalunguta	16	7	43,8%				0
Katwa	368	246	66,8%	8	5		5
Kyondo	16	12	75,0%				0
Lubero	1	1	100,0%				0
Mabalako	3	2	66,7%				0
Manguredjipa	1	0	0,0%	1	0		0
Masereka	7	4	57,1%				0
Musienene	74	43	58,1%	2	0		0
Mutwanga	1	1	100,0%				0
Oicha	7	5	71,4%	0	0	1	1
Vuhovi	5	2	40,0%				0
Haut-Uélé	194	90	46,4%	5	0	1	1
Boma Mangbetu	26	14	53,8%				0
Gombari	3	1	33,3%				0
Isiro	78	32	41,0%	4	0	0	0
Pawa	20	16	80,0%	0	0	1	1
Rungu	1	0	0,0%				0
Wamba	66	27	40,9%	1	0	0	0
Tshopo	17	8	47,1%	2	0	0	0
Bafwasende	1	0	0,0%				0
Kabondo	3	1	33,3%				0
Lubunga	1	0	0,0%				0
Makiso-Kisangani	8	4	50,0%	2	0	0	0
Mangobo	2	2	100,0%				0
Tshopo	1	0	0,0%				
Wanie-Rukula	1	1	100,0%				0
Sud-Kivu	3	1	33,3%	0	0	0	0
Miti-Murhesa	3	1	33,3%				0
Bas Uélé	3	1	33,3%	0	0	0	0
Buta	1	1	100,0%				0
Viadana	1	0	0,0%				
Ganga	1	0	0,0%				
Total	5794	2786	48,1%	81	35	7	42

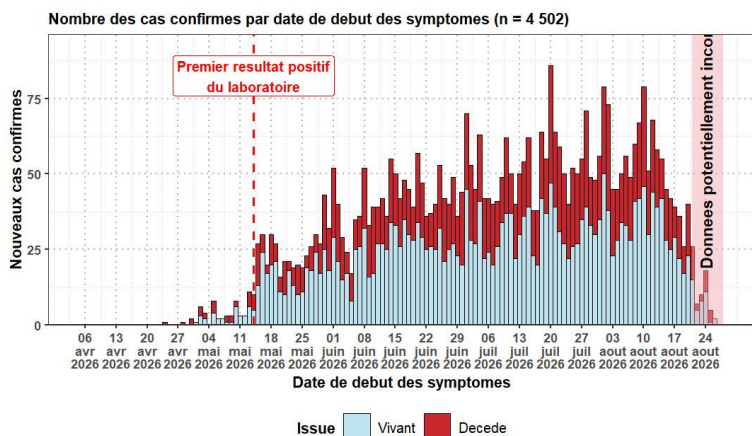
*Il s'agit des décès confirmés survenus dans les différents CTE de la province et sont en cours de ventilation pour être classifié par zone de santé.

NA : Non Applicable.

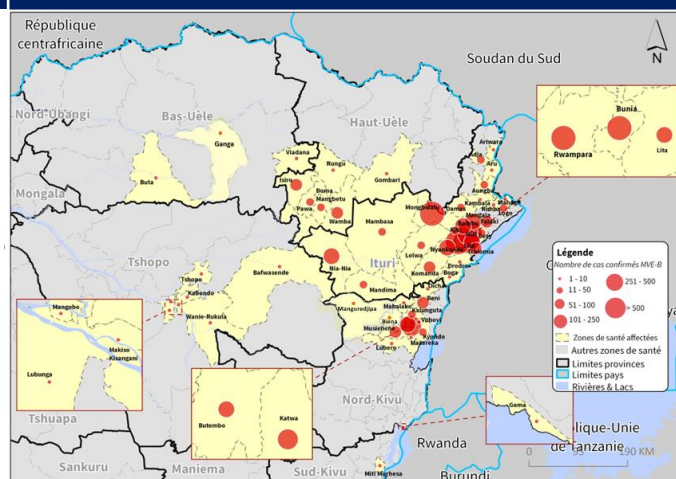
Situation des alertes notifiées par province, au 26 août 2026

DPS	Nouvelles Alertes Reçues		Total alertes	Alertes vérifiées et validées (cas suspect)		Alertes vérifiées et invalidées (non-cas suspect)		Nombre de suspects investigués	Nombre de suspects investigués et transférés au CT/CTE (du jour)
	Vivants	Décédés		Vivants	Décédés	Vivants	Décédés		
Haut-Uélé	11	3	14	11	3	0	0	14	10
Bas Uélé	14	1	15	4	1	9	0	5	1
Ituri	660	66	726	197	59	297	59	256	118
Nord-Kivu	1 014	55	1069	98	48	683	7	146	63
Sud-Kivu	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Tshopo	202	0	202	10	0	192	0	10	8
Total Général	1901	125	2 026	320	111	1181	66	431	200

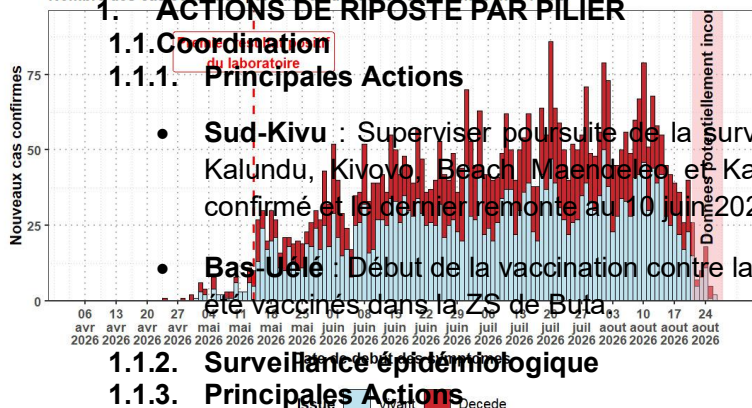
Évolution de cas par date de début des symptômes au cours de 21 derniers jours



CARTOGRAPHIE DES CAS de 21 derniers jours



Nombre des cas confirmés par date de début des symptômes (n = 4 502)



ces vérifications, 431 (25,7 %) ont été validées comme cas suspects et tous ont été investigués, soit 100,0 %, parmi lesquels 200 ont été transférés vers les CT/CTE.

La proportion des contacts suivis au cours des dernières 24 heures se situe à 82,3 % (22 091 vus sur 26 850 à suivre), en dessous du seuil de 85 % : Ituri 85,6 % (13 706/16 010), Tshopo 100,0% (308/308), Nord-Kivu 80,5 % (6 877/8 541), Haut Uélé 61,0% (1 033/1 694) et Bas Uélé 56,2% (167/297).

1.1.4. Défis

Faible suivi des contacts autour des cas confirmés principalement dans les provinces du Bas et Haut Uélé lié à une insuffisance des équipes dédiées à ces activités.

1.2. Point sur les activités de points de contrôle et points d'entrées (PoC/PoE)

1.2.1. Principales actions

- Quatorze (14) alertes ont été notifiées aux PoE/PoC au cours des dernières 24 heures : trois en Ituri au PoC Mudzi Bala (ZS Bunia), toutes validées, isolées et référées au CT Bunia et au CT Elikia ; six au Nord-Kivu au PoC Foner Kasindi (ZS Mutwanga), dont quatre validées et deux invalidées après investigation ; deux au Haut-Uélé au PoC Magambe (ZS Isiro), dont une alerte vivante validée et référée au CTE Tuluba et un corps sans vie intercepté, relâché par la sécurité avant le swab ; trois au Bas-Uélé au PoC PK5 route Nesu (ZS Viadana), toutes invalidées après investigation.

Indicateurs	Ituri	Nord-Kivu	Sud-Kivu	Tshopo	Haut-Uélé	Bas-Uélé	Global
Complétude des rapports	98,3 % (59/60)	100 % (18/18)	55,5 % (5/9)	85,7 % (6/7)	54,5 % (6/11)	50,0 % (10/20)	83,2 % (104/125)
% des PoE/PoC stratégiques fonctionnels	9,09 % (1/11)	100 %	NA	35 % (7/20)	54,5 % (6/11)	ND	ND
Nombre de personnes passées aux PoE/PoC	149 443	87 183	7 678	5 510	7 971	3 617	261 402
% des voyageurs screenés	98,0 %	97,91 %	98,3 %	99,3 %	96,0 %	99,4 %	98,0 %
% des voyageurs ayant lavé les mains	97,4 %	97,91 %	98,3 %	99,1 %	96,0 %	99,4 %	97,6 %
% des voyageurs sensibilisés	99,3 %	97,91 %	100 %	100 %	96,0 %	99,4 %	98,8 %
Nombre d'alertes notifiées	3	6	0	0	2	3	14
Nombre d'alertes vivantes validées (cas suspects)	3	4	0	0	1	0	8
Nombre de corps sans vie interceptés ce jour	0	0	0	0	1	0	1
% des cas suspects transférés au CT/CTE	100 % (3/3)	100 % (4/4)	0 %	0 %	100 % (1/1)	NA	100 % (8/8)
% des corps sans vie swabés/sécurisés	0 % (0/0)	0 %	0 %	0 %	0 % (0/1)	NA	0 % (0/1)
% des cas suspects investigués dans 24 h	100 % (3/3)	100 % (4/4)	0 %	0 %	100 % (1/1)	100 % (3/3)	100 % (11/11)

1.2.2. Défis

Opérationnalisation insuffisante des PoE/PoC : la complétude nationale se situe à 83,2 % (104 rapports sur 125), avec des niveaux faibles au Haut-Uélé (54,5 %) et au Sud-Kivu (55,5 %). En Ituri, 1 (9,1 %) des 11 PoE/PoC stratégiques fonctionne sans interruption et le PoC d'Avakubi reste non fonctionnel pour raisons sécuritaires ; au Haut-Uélé, cinq PoC (Dusu, Apodo,

Aungba, PK6 Route Niangara et Gossamu) n'ont pas rapporté leurs données en raison d'une grève liée à la non-rémunération des prestataires ; à la Tshopo, 7 PoC sur 20 seulement sont activés.

1.3. Laboratoire

1.3.1. Principales actions

- **Ituri : 52 nouveaux résultats positifs** (31 vivants et 21 décès) sur 152 nouveaux échantillons reçus et analysés (**positivité : 34,2 %**).
- **Tshopo : 2 nouveaux résultats positifs sur 12 échantillons (positivité : 16,7%) ; dotation officielle de kits de prélèvement et de consommables de laboratoire par JHPIEGO.**
- **Nord-Kivu : 22 nouveaux résultats positifs** (8 vivants et 14 décès) sur 185 échantillons analysés (**positivité de 11,9 %**).
- **Haut-Uélé : 5 nouveaux résultats positifs** (5 vivants et 0 décès) sur 21 échantillons analysés (**positivité de 23,8 %**).
- **Bas-Uélé : 2 échantillons reçus et testés à Buta, aucun résultat positif.**

1.4. Prévention et Contrôle de l'Infection (PCI/EDS)

1.4.1. Principales actions

- **En Ituri**, 31 rings ont été ouverts sur les 50 identifiés (62,0 %), 65 ménages décontaminés sur 68 identifiés (95,6 %) et 8 FOSA sur 8 (100 %) ; 3 évaluations de FOSA ont été réalisées et 5 kits PCI ont été dotés aux ménages. Le pilier EDS a reçu 87 alertes : 65 corps swabés, 78 EDS réalisés et 5 reports en fin de journée.
- **Au Nord-Kivu**, 5 FOSA sur 10 ont été décontaminées (50 %) et 48 FOSA ont été accompagnées ; 7 FOSA ont été évaluées (score moyen 26,7 %) et le risque d'exposition de 4 PPL évalué. Le pilier EDS a reçu 54 alertes (17 reports) : 37 corps swabés, aucun échec pour les alertes du jour, 43 EDS réalisés et 11 reports du jour.

1.4.2. Défis

- Faible mise en œuvre des normes de PCI : en Ituri, l'ouverture des rings reste limitée à 62,0 % et échecs de swab ont été enregistrés ; insuffisance d'équipes de décontamination à Fataki et Mangala et manque de mobilité à Komanda, Bambu et Mangala.
- Au Nord-Kivu, aucune décontamination des lieux de séjour des cas confirmés n'a été réalisée et les équipes de décontamination font défaut dans les ZS nouvellement touchées.
- À la Tshopo, insuffisance d'EPI dans les ESS et panne de l'incinérateur de l'HGR Makiso-Kisangani.

1.5. Continuité des soins

1.5.1. Principales actions

- **En Ituri**, 111 nouvelles admissions ont été enregistrées et 85 sorties dont 12 guéris. Ainsi, 549 patients sont hospitalisés pour 978 lits, soit un taux d'occupation global de 56,1%.

- **Au Nord-Kivu**, 69 admissions ont été enregistrées contre 33 sorties dont 1 guéri. Au terme de la journée, 214 patients sont hospitalisés pour 206 lits, soit un taux d'occupation global de 103,9 %.
- **À la Tshopo**, 2 nouvelles admissions de cas suspects et 11 patients isolés pour 14 lits, soit 78,6% d'occupation.
- **Au Haut Uélé**, 17 admissions ont été enregistrées (3 confirmés et 14 suspects) contre 15 sorties dont 11 guéris. Ainsi, 68 patients sont en isolement, soit 56,7% des lits occupés.

1.5.2. Défis

Faible capacité d'accueil et absence de CTE dans certaines zones de santé : saturation du CTE de Bambu (confirmés) et du CT Kigonze (suspects) en Ituri ; dépassement de la capacité en lits suspects au Nord-Kivu (175 patients pour 142 lits), où une partie des suspects de Butembo, Masereka, Vuhovi et Kalunguta est isolée dans des ESS qui ne sont pas des centres de traitement ; à la Tshopo, capacité d'accueil du CTE limitée à 14 lits.

1.6. Communication sur les risques et engagement communautaire

1.6.1. Principales actions

- **En Ituri**, 270 personnes ont été touchées autour des cas confirmés (67 à Mambasa, 95 à Nia-Nia, 45 à Mangala, 38 à Bunia et 25 à Lolwa) ; couverture médiatique de la sortie de 9 guéris du CTE Rwankole et de 10 guéris des CTE Bunia, CME et Elikya ; 46 EDS et swabs facilités dans les ZS de Mangala, Bunia, Tchomia, Komanda, Bambu et Nizi ; engagement du Chef de groupement Bandjabulu lors d'un dialogue communautaire dans l'AS Nzere.
- **À la Tshopo**, Poursuite de la sensibilité les visites à domicile dans 186 ménages de Makiso, Mangobo et Kabondo.
- **Au Nord-Kivu**, briefing de 20 leaders religieux à Beni assorti d'une visite guidée du CTE et de 90 membres du mouvement culturel OURAN dans les ZS de Katwa et de Butembo ; tenue de réunions avec les députés nationaux et provinciaux à Katwa et à Butembo ; séance de clarification à l'intention des responsables de l'éducation ; préparation communautaire à la décontamination dans les ZS de Katwa, Butembo, Kyondo, Beni et Vuhovi.
- **Au Haut-Uélé**, campagne de sensibilisation et d'engagement communautaire sous le haut patronage du Gouverneur de province : 582 personnes sensibilisées le 22 août à la résidence officielle et plus de 5 200 le 25 août à Ibambi (territoire de Wamba) ; déchargement de 3 guéris à Ibambi (ZS Pawa) ; 6 cas couverts et 5 responsables de ménage touchés à Isiro et à Wamba ; 1 incident communautaire résolu à Isiro.
- **Au Bas-Uélé**, Réalisation d'une émission radio avec la société civile et la task-force CREC à Buta et à Bondo ; réception de matériel de sensibilisation de FHI 360 (6 baffles, 6 mégaphones et 6 clés USB).

1.6.2. Défis

Persistance de défis au niveau communautaire : en Ituri, refus de prélèvement à Nia-Nia et Alimasi, réticence à Kabakaba et refus de listage des contacts à Kilo État (48 cas) ; au Nord-Kivu, résistances communautaires à Katwa, Butembo, Kalunguta et Beni et assassinat d'un président de cellule d'animation communautaire dans l'AS Mangothe (ZS de Beni) ; à la Tshopo, résistances aux investigations, prélèvements et transferts au CTE.

1.7. Santé mentale et soutien psychosocial (SMSPS)

1.7.1. Principales actions

- **En Ituri**, 10 nouveaux cas confirmés et 110 cas confirmés en cours de suivi ont bénéficié d'interventions SMSPS, ainsi que 31 nouveaux suspects et 119 suspects en cours de suivi ; 44 ménages ont été accompagnés, 29 PPL soutenus, 75 enfants suivis en communauté et 7 en crèche ; 47 annonces de résultats ont été réalisées dont 10 positives et 11 guéris sur 12 (92 %) ont été réinsérés. La couverture reste limitée à 5 des 9 ZS ayant notifié.
- **Au Nord-Kivu**, 55,3 % nouveaux suspects ont bénéficié d'interventions SMSPS ; 89 annonces de résultats ont été réalisées dont 18 positives, 24 ménages accompagnés, 42 PPL soutenus, 30 enfants suivis en communauté et 4 guéris réinsérés (100 %).
- **Au Haut-Uélé**, 4 nouveaux cas confirmés (3 à Isiro et 1 à Pawa) et 20 cas confirmés en cours de suivi ont bénéficié d'interventions SMSPS, ainsi que 9 nouveaux suspects et 1 suspect en cours de suivi ; 46 accompagnants et 25 PPL ont été soutenus, 21 annonces de résultats réalisées dont 5 positives et 1 EDS appuyé.
- **Au Bas-Uélé**, 1 résultat de laboratoire a été annoncé à Buta, 3 PPL ont bénéficié d'interventions SMSPS et 1 contact a été soutenu.

1.7.2. Défis

Au Haut Uélé, couverture SMSPS insuffisante. **Au Nord-Kivu**, seules 4 ZS sont couvertes par des interventions autour des derniers cas et les crèches font défaut dans les CTE. **En Ituri**, aucune couverture à Bambu, Nia-Nia, Mambasa et Lolwa.

1.8. Logistique

1.8.1. Principales actions

Livraison de 40 kits de dignité (don UNFPA) à la ZS de Beni et de 8 à la ZS de Kalunguta, de 9 cartons de cache-nez GF et 20 cartons PF à Beni et de 2 cartons GF et 6 PF à Kalunguta, ainsi que des intrants du projet continuité des soins (don UNICEF) aux ZS de Kalunguta et de Butembo. À la Tshopo, suivi de la construction des unités d'isolement de Madula et de Kabondo et du CTE de grande capacité, installation des matériels et équipements du laboratoire de santé publique de Kisangani (IMBOLO), dotation d'une moto au PK 23 pour l'approvisionnement en eau et décongélation des vaccins en prévision de la vaccination.

1.9. Sécurité

1.9.1. Principales actions

- **Au Nord-Kivu**, couverture sécuritaire des équipes PCI dans les AS de Butsili, Madrandele et Kanzunzulili ainsi qu'au CS Nyakunde ; accompagnement de l'équipe EDS au cimetière de Bundji pour l'enterrement de 4 corps de cas confirmés et pour des swabs au CH Peregrin et au CH Don Divin ; supervision et évaluation sécuritaire au PoE Kyaghala et au PoC Kitakandi.

1.9.2. Défis

La sécurisation des PoC stratégiques reste incomplète : au Haut-Uélé, le corps sans vie intercepté au PoC de Magambe (ZS Isiro) a été relâché par la sécurité sans avoir pu être swabé. Au Nord-Kivu, l'insécurité persiste dans les zones d'enterrement et la route menant au cimetière de Bundji (ZS de Beni) reste impraticable.

1.10. PSEA (Prévention contre l'Exploitation et les Abus Sexuels)

1.10.1. Principales actions.

En Ituri, formation et briefing de 22 participants (16 hommes et 6 femmes) sur la PSEAH lors de la formation de la prise en charge (ZS Bunia) ; sensibilisation de 128 personnes dans les AS de Mudzimaria (93 participants) et de Bigo (35 participants) ; poursuite de l'affichage des messages et de la distribution de dépliants dans les ZS de Bunia, Aru, Rwampara et Mongbwalu.

1.10.2. Défis

- Couverture encore insuffisante des activités PSEA : 25 % des zones de santé de l'Ituri (9/36) connaissent le mécanisme de signalement et seuls 2 partenaires (OMS et IMC) rapportent leurs activités PSEA ; absence de cartographie des intervenants ; insuffisance de supports de sensibilisation de masse ; manque de moyens de transport et d'équipement informatique pour le pilier.

MESSAGES CLES

- La transmission de la MVE reste active, avec 81 nouveaux cas dont 35 décès communautaires et 7 intra- CTE enregistrés au cours des dernières 24 heures, portant le cumul national à 5 794 cas confirmés et 2 786 décès.
- Deux nouvelles ZS touchées dans la province du Nord-Kivu (Biena et Manguredjipa).
- L'Ituri demeure l'épicentre de l'épidémie, concentrant 82,9 % des cas confirmés cumulés et 64,2% des nouveaux cas rapportés au cours des dernières 24 heures et une expansion plus importante (28 des 36 ZS affectées).
- La surveillance affiche une faible performance (68,0%) des cas suspects investigués tandis que le taux de suivi (82,3%) en dessous du seuil de 85,0%.
- Le renforcement des interventions prioritaires (surveillance, prise en charge, PCI, logistique et engagement communautaire) demeure essentiel

CHRONOLOGIE DES FAITS CLÉS

- Du 24 avril au 15 mai 2026, l'épidémie est passée de la détection des premiers cas suspects à la confirmation biologique du virus Ebola Bundibugyo, conduisant à la déclaration officielle de la 17^e épidémie de Maladie à Virus Ebola en République Démocratique du Congo.
- Entre le 17 et le 18 mai 2026, les autorités nationales, avec l'appui des partenaires, ont renforcé la riposte par la déclaration de l'urgence de santé publique de portée nationale puis continentale, accompagnée de la mobilisation des fonds.



TASK FORCE PRESIDENTIELLE EBOLA 17
Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale
Institut National de Santé Publique
Centre d'Opérations d'Urgence de Santé Publique
Système de gestion de l'incident MVE17

Directeur Général de l'INSP

Dr MWAMBA KAZADI Dieudonné

E-mail : dieudonne.mwamba@insp.cd

Incident Manager

Professeur Dr AHUKA MUNDEKE Steve

E-mail : steve.ahuka@unikin.ac.cd

Chargé des opérations

Dr Kombe NGWAMA John

Equipe rédaction

Professeur Dr Mulangu Katulumba Félix-Médard

Dr Katusi Biselenge Jules

Madame Mayele Afua Marie

Dr Diur Mananashi Floryan

Mr Kamuina Kebela John

Contact :

www.insp.cd

contact@sgiebola17.org

Numéro vert : 151. www.sante.gouv.cd